

12 - 02- Les Troubles Bipolaires - Pr. Manoudi

Bonjour, aujourd'hui on va voir les troubles bipolaires. Les troubles bipolaires font partie des troubles de l'humeur et sont définis par la récurrence d'épisodes de manie ou d'hypomanie avec ou sans épisodes dépressifs. Même s'il n'y a pas d'épisodes dépressifs, on parle de troubles bipolaires.

Ça atteint surtout les sujets jeunes avec un risque élevé de tentative de suicide ou de suicide qui peut survenir lors de l'accès maniaque ou bien lors de l'accès dépressif. Le traitement préventif est d'un intérêt capital parce qu'il va éviter les rechutes et éviter les complications graves, notamment les suicides. C'est un syndrome qui est complexe avec une physiopathologie inconnue qui atteint 1% de la population mondiale et au moins 50% de la clientèle des hôpitaux psychiatriques.

Déjà, Kreplin a fait la séparation psychose-maniaco-dépressive. Donc la récurrence des deux phases maniaque et dépressive. Leonard, elle a séparé les troubles bipolaires des troubles unipolaires et Shaw a parlé de l'intérêt préventif du lithium.

Après les DSM, dans les DSM, on va voir l'évolution et la distinction entre les deux types bipolaire et unipolaire. Donc vous voyez ici, au début on l'appelait maladie maniaco-dépressive. Après, on a séparé les troubles unipolaires des troubles bipolaires de la personnalité cyclothymique.

Les troubles unipolaires sont définis par la récurrence d'épisodes dépressifs majeurs. Les troubles bipolaires, on les distingue de type bipolaire type 1 où on a soit la récurrence d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs majeurs, soit la récurrence d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs mineurs, soit la récurrence que d'épisodes maniaques. Même s'il n'y a pas d'épisodes dépressifs, on parle de bipolaire parce qu'on dit qu'il y a toujours un épisode dépressif qui est passé inaperçu.

Alors que le bipolaire type 2, c'est la récurrence d'épisodes dépressifs et hypomaniaques. Donc il faut les deux. La cyclothymie est définie par la récurrence d'épisodes hypomaniaques et d'épisodes dépressifs mineurs.

Ici aussi, il faut la récurrence des deux. Alors j'insiste sur le trouble bipolaire type 1. C'est la récurrence d'épisodes maniaques, donc il faut absolument avoir des épisodes maniaques et la présence ou pas d'épisodes dépressifs. Donc rien que la récurrence d'épisodes maniaques seule donne un trouble bipolaire type 1. Le trouble bipolaire type 2 est défini par la récurrence d'épisodes dépressifs majeurs et d'épisodes hypomaniaques.

Donc il faut les deux et il faut un épisode dépressif majeur. La prévalence sur la vie du trouble bipolaire est différente en fonction du type du trouble. Le trouble bipolaire type 1 varie de 0,4 à 1,6%.

Il atteint les deux sexes de la même façon. La prévalence du trouble bipolaire type 2 est de 0,5%. Il atteint plus les femmes que les hommes parce qu'on a dit dans le trouble bipolaire type 2 il y a la récurrence d'épisodes dépressifs.

On sait que les dépressions sont fréquentes chez les femmes. Les troubles cyclotimiques, la prévalence est de 0,4 à 1%. En général, le trouble bipolaire atteint les hommes comme les femmes.

L'âge moyen de début du trouble est de 21 ans. Mais la pathologie peut débuter précocement vers 15 ans. Donc la tranche d'âge 15-19 ans est la plus fréquente.

Le délai moyen avant le premier traitement est de 5 à 10 ans. Donc souvent on a des retards diagnostiques et des retards thérapeutiques avec un pic de fréquence entre 15 et 30 ans. En général, après 60 ans, c'est rare.

Si on a une symptomatologie d'allure maniaque, il faut chercher une pathologie organique autre qui peut commencer par un aspect typiquement maniaque. 7 patients sur 10 sont initialement mal diagnostiqués. Et 30% des patients consultant pour des symptômes dépressifs peuvent avoir un trouble bipolaire.

C'est pour ça que j'ai insisté dans le dernier cours des troubles dépressifs. Il faut chercher les antécédents personnels et les antécédents familiaux de troubles de l'humeur. Que ce soit des hypomanies ou bien de manie.

Ça peut carrément changer le diagnostic ou bien changer le traitement. 1 patient sur 3 est à la demande des soins pendant 10 ans avant d'être correctement diagnostiqué. Ce retard diagnostique va entraîner un retard thérapeutique et bien sûr peut entraîner des conséquences graves.

On peut avoir l'association d'une autre entité diagnostique, notamment les troubles anxieux, dans plus de 50% des cas. Et parmi les troubles anxieux les plus fréquemment associés avec le trouble bipolaire, on note le trouble obsessionnel-compulsif et le trouble de panique. Et dans 60% des cas, les troubles bipolaires type 1 sont associés à un abus de substance.

Ici l'étude dont on a parlé la dernière fois, qui a été faite à l'échelle marocain et qui a concerné 6000 sujets, la prévalence des épisodes maniaques est de 3,2% dans cette étude. Alors on va prendre comme type de description le trouble bipolaire type 1. On a dit qu'il est défini par la récurrence d'épisodes maniaques avec ou sans épisodes dépressifs. L'épisode maniaque va se manifester soit brutalement, soit rapidement progressive.

Et en général, il se manifeste par les mêmes symptômes au cours des rechutes suivantes. Donc on peut avoir une insomnie sans hasténie, insomnie sans fatigue. Le sujet peut dormir que 2 ou 3 heures ou même des fois peut faire des nuits blanches et même des fois des nuits blanches

successives.

Et le lendemain il est en forme, avec un sentiment de bien-être, de joie extrême, avec une modification de caractère et va commencer à faire des projets multiples. Il est hyperactif, il est désinhibé, avec des troubles de comportement type d'irritabilité, d'agressivité. Et en cherchant les antécédents familiaux, on peut trouver des troubles chimiques.

Et parfois, dans les antécédents personnels, on peut trouver des antécédents judiciaires la même période de l'année. Et ça, cette périodicité des troubles peut nous orienter vers le diagnostic. La phase d'état, déjà à la présentation du patient, on peut être orienté.

Donc le patient va se présenter par des tenues extravagantes, des tenues flashantes, avec des couleurs flashants qui attirent l'attention. Parfois un désordre dans sa tenue parce qu'il est hyperactif. Il n'a pas le temps de bien ranger sa tenue.

Et parfois même, il va se présenter torse nu ou carrément nu. Une hyper mimie, un regard brillant et des rires qui sont intenses. Et au niveau déjà de la salle d'attente ou bien si vous êtes dans votre cabinet, vous le voyez déjà avec un contact et une présentation qui attirent l'attention.

Donc il est familier dans son contact et va commencer à saluer tout le monde au niveau de la salle d'attente, saluer le personnel comme s'il faisait partie de sa famille. Et des fois même, il va s'en moquer d'eux, il va les taquiner. Et parfois, il peut prendre un temps hautain avec eux, avec ce qu'on appelle une hypersynthonie.

Au cours de l'entretien, son attention est attirée par les différents stimulus. Il est là à répondre à vos questions en même temps. Il fait attention à ce qui se passe à l'extérieur.

Au niveau du langage, on l'a ulogoré. Il ne va pas vous laisser placer un mot. C'est des gens qui vont parler beaucoup avec des mots des fois obscènes.

Il peut vous répondre par des mots obscènes. L'humeur, on note une exaltation de l'humeur avec une joie qui est extrême, qui est très importante. Un bien-être extrême, morbide, un optimisme et une insouciance totale.

On note aussi une versalité et une instabilité de l'humeur. Au niveau intellectuel, on note une taquipsychie. Ce sont des idées qui vont défiler rapidement avec une association par assonance.

Dans ses réponses, il va choisir des mots qui ont le même son et faire des associations entre les mots. Ils peuvent répondre par des jeux de mots. Ils peuvent répondre par des proverbes.

Et on note aussi une fuite d'idées. Le patient n'arrive pas à se contrôler. Il a cette impression que les idées défilent rapidement.

Et ça vous donne, au cours de l'entretien au niveau du langage, un aspect de kokalane. Mais le

discours est cohérent. Mais c'est les pensées qui défilent rapidement.

Une intention qui est dispersée. Avec des idées délirantes, mégalomaniaques. Il se sent le plus fort, le plus intelligent, le meilleur.

Il est mieux que vous. Il ne va pas vouloir vous écouter et ne répondre à vos questions. Parce qu'il est mieux instruit.

Il a fait plus d'études que vous. Avec une surestimation de soi. Un sentiment de toute puissance.

Il peut tout réussir. Et bien sûr, il va faire des projets multiples. Même s'il n'a pas de moyens.

Il va vous donner toutes les idées pour faire des projets multiples. Au niveau instinctuel, on a dit qu'il y a une insomnie sans fatigue, sans asthénie. Avec une hyperphagie.

Mais après, il y a un amaigrissement. Parce que le patient est hyperactif. On a aussi une hypersexualité.

Qui peut avoir des risques graves pour le patient et pour les autres. Et un pouvoir, il va être manipulateur et séducteur. Au niveau des troubles de comportement, on note des dépenses exagérées.

Donc des dépenses qui peuvent avoir des conséquences graves. Il peut complètement perdre son capital financier. En un jour ou deux jours, perdre tout son argent.

Une hyperactivité, une agitation, agressivité. Il peut se faire du mal ou bien faire du mal aux autres. Un ludisme dans son contact avec les autres.

Il va commencer à chanter, danser, se déguiser. Et on note aussi une absence de pudeur. Et un pouvoir séducteur.

Toujours à la phase d'état, on peut noter une multiplication des initiatives. Ce sont des gens hyperactifs qui vont commencer tout, mais ne finissent rien. Que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel.

On note aussi un désir soudain de s'amuser dans des lieux publics. Des lieux inappropriés, à des heures inappropriées. Ils vont commencer à chanter, à danser.

Des voyages pathologiques, souvent présents. Avec un absentéisme ou un relâchement professionnel. On a déjà dit des inhibitions financières.

Avec des assas multiples et pathologiques. Ils peuvent carrément perdre beaucoup d'argent. Et ils sont inconscients de leurs troubles.

L'évolution de l'accès maniaque peut se faire par la répétition des accès. On parle de troubles

bipolaires à partir du deuxième accès. Les accès surviennent souvent suite à des facteurs déclenchants.

Il faut toujours chercher les facteurs déclenchants pour essayer de les traiter aussi. Et on note une périodicité des troubles. Il y a des risques liés à la manie.

C'est pour ça qu'il faut diagnostiquer précocement et traiter précocement. On peut avoir une désinsertion socio-professionnelle. Avec son RTA, le patient peut avoir des problèmes dans son travail.

Avec ses supérieurs hiérarchiques. Et il peut être licencié. Des conduites à risque.

On a dit qu'il est désinhibé avec hypersexualité. Il peut avoir des rapports sexuels non protégés. On peut aussi noter une errance, un vagabondage.

Et une délapidation du capital financier. On a dit qu'il peut avoir des dépenses excessives. Des comportements hétéro-agressifs.

Voire même des comportements auto-agressifs et suicidaires. On peut aussi noter des développements d'addiction. Surtout l'addiction à l'alcool qui va aggraver cet accès maniaque.

Dans les formes les plus agitées, on peut trouver un épuisement. Une dénutrition. Et carrément des déshydratations.

Donc là, on voit les critères diagnostiques de l'épisode maniaque par le DSM. C'est une période délimitée de minimum une semaine d'humeur élevée. De façon anormale et persistante.

Et on doit avoir au moins trois des symptômes suivants de BA à B7. Il ne doit pas y avoir un épisode mixte. Et une altération marquée du fonctionnement psychosocial ou une hospitalisation.

Et ce n'est pas un trouble qui est dû à une substance ou à une maladie générale. Les troubles de BA à B7, c'est le trouble qu'on a vu dans les formes cliniques. Donc c'est une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur.

Réduction du besoin du sommeil, insomnie, son fatigue. Fuite des idées, distractibilité, plus grande communicabilité ou logorée. Augmentation de l'activité sociale, professionnelle, sexuelle ou scolaire.

Augmentation d'activités agréables mais dommageables. Alors l'épisode dépressif, on peut avoir tous les degrés de l'humeur dépressive. D'intensité mineure jusqu'à la mélancolie.

C'est toutes les formes qu'on a vu la dernière fois. Donc pour rappel, le début est progressif. Ça peut commencer par une insomnie, une fatigue, des pleurs.

Ou bien ça peut être un début brutal par des tentatives de suicide. Donc toujours chercher,

j'insiste, des antécédents familiaux, de troubles chimiques. Et parfois des antécédents judiciaires à la même période.

Ça, quand le patient va se présenter chez vous durant la phase dépressive. La phase d'état, comme on a dit la dernière fois. Au niveau de la présentation, on a des signes caractéristiques.

Qui sont l'incurie, la prostration, l'hypomémie. Au niveau du contact, c'est un contact qui est long, évitant. Le patient est insensible sauf à sa douleur, la souffrance morale.

Au niveau du langage, on note un mutisme, un temps monocorde. Un discours qui est pauvre, l'humeur, elle est triste. Elle est abaissée avec des pleurs au cours de l'entretien.

Un sentiment de catastrophe, un pessimisme, un sentiment d'incurabilité. Et des idées noires ou idées suicidaires. Au niveau intellectuel, on a une bradicardie, sensation pénible de vide.

Un mono-idéisme, une autodépréciation. Et des idées délirantes congruentes à l'humeur. Donc des idées négatives.

Et il n'y a pas de projet d'avenir. Sur le plan instinctuel, on a l'insomnie du petit matin. Ou bien on peut avoir une hypersomnie.

Une anorexie avec un maigrissement, refus alimentaire, baisse de la libido. Et au niveau comportemental, on a un ralentissement, une inhibition ou une clinophilie. Donc l'épisode dépressif, c'est tout à fait l'image au miroir, le contraire de ce qu'on a vu dans l'accès maniaque.

Le trouble bipolaire type 2, on a dit, c'est une alternance d'épisode dépressif majeur avec accès hypomaniaque. L'accès hypomaniaque, on va le voir par la suite, c'est une forme atténuée de la manie. Alors l'épisode trouble bipolaire type 3, c'est la récurrence d'état dépressif majeur avec un virage franc maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseur.

Le trouble cyclothymique, c'est la récurrence d'accès hypomaniaque et d'accès subdépressif, ou bien une dépression minime, pendant une période de moins de 2 ans. L'état mixte, au cours du même accès, on a des symptômes de l'état dépressif majeur et des symptômes de l'accès maniaque ou de l'hypomanie tous les jours pendant au moins une semaine. Donc chaque jour, on a la présence des deux symptômes en même temps.

Des fois, elle est triste, déprimée, des fois, elle est excitée, euphorique. Au cours de la même journée, on a l'alternance des deux symptômes et ce, tous les jours pendant au moins une semaine. On parle de trouble bipolaire à cycle rapide, que ce soit le trouble bipolaire type 1 ou type 2, si on a au moins 4 épisodes maniaques ou dépressifs par an.

Donc les troubles bipolaires, c'est les récurrences des troubles maniaques ou dépressifs. Donc si on a la répétition de moins 4 épisodes par an, on parle de troubles bipolaires à cycle rapide. On a d'autres formes ou bien des équivalents de troubles bipolaires, notamment l'alcoolisme

périodique.

Aussi, ça se répète au cours de la même période. On a aussi les troubles bipolaires avec symptomatologie délirante, avec des symptômes psychotiques et on a la manie chronique. L'hypomanie, il faut bien la diagnostiquer, il faut bien la repérer, il faut bien poser des questions dans ce sens.

Alors, ce n'est pas un signe de sévérité et on n'a pas d'éléments psychotiques au cours de l'hypomanie. Donc il n'y a pas de délire, il n'y a pas d'hallucination au cours de l'hypomanie. En général, c'est un état qui ne nécessite pas l'hospitalisation.

Le changement peut être observé par l'entourage et les symptômes ne sont pas dus à une substance ou à une infection médicale. Dans l'hypomanie, on a un côté soleil, un côté qui peut apparaître un petit peu normal. Donc il y a des gens autour de vous, vous allez voir qu'ils ont un petit peu ce fonctionnement.

Ce sont des gens qui ont moins d'heures, qui ont besoin de moins d'heures de sommeil. Ils ont plus d'énergie, plus de confiance en soi, plus de motivation au travail, plus d'activité sociale, surcroît d'activité physique, plus de projets et d'idées créatives, moins de timidité, plus bavard, plus optimiste, euphorique, avec des rires, des calembours et des pensées plus rapides. Mais ça n'atteint pas l'extrême, c'est pas au-delà de la normale.

L'hypomanie a aussi un côté sombre, plus de déplacements, plus de voyages, plus de prise de risque, dépenses excessives avec des comportements déraisonnables dans les affaires. Ils prennent plus le risque, plus d'impatience et d'irritabilité et une concentration diminuée parce qu'ils ont une pensée qui est dispersée et une augmentation des pulsions sexuelles, un petit peu sont désinhibées et ça donne beaucoup plus à l'alcool, aux caféines et à la nicotine, aux excitants et aux drogues. Pourquoi il faut rechercher les symptômes de l'hypomanie ? Parce qu'ils ne sont pas rapportés spontanément par le patient et quand vous faites le diagnostic d'une hypomanie, vous avez vu dans le graphique, ça change complètement le diagnostic du trouble et ça peut changer le traitement.

Ils ne sont pas perçus comme pathologiques, vous avez vu le côté soleil de l'hypomanie, c'est pas vraiment quelque chose perçu de pathologique. Ils sont perçus parfois comme socialement avantageux et positifs. Ils ne sont pas associés à une souffrance psychique et ne nécessitent de collecter la vie.

Il faut poser la question à l'entourage pour pouvoir poser ce diagnostic. Et bien sûr, comme on a dit, il oriente vers le diagnostic de trouble bipolaire. Donc si vous le détectez chez un patient qui fait des dépressions majeures, ça vous donne le diagnostic de trouble bipolaire type 2. Dans le trouble bipolaire, on a dit qu'on note une périodicité du trouble qui est variable selon le sujet.

Il y a des sujets qui vont faire 2 accès maniaques par an et 1 accès dépressif. Il y a des sujets qui

vont faire 1 accès maniaque tous les 4 ans et 1 accès dépressif par exemple tous les 2 ans. Donc c'est très variable et c'est en fonction des sujets.

Sans traitement, bien sûr, il va y avoir aggravation et augmentation de la fréquence des accès. C'est ça le risque, quand on ne traite pas, les rechutes augmentent. Et bien sûr, ça va aggraver l'état du sujet.

Et aussi, on peut avoir des complications qui peuvent être graves, notamment les tentatives de suicide et les suicides. Les suicides peuvent survenir durant l'accès dépressif, mais aussi durant l'accès maniaque. Même si le patient est euphorique, joyeux, hyperactif, il peut passer à l'acte.

Soit dans un état délirant, il va se sentir immortel et il peut passer à l'acte. Soit au cours de l'hyperactivité, il ne va pas faire attention et il peut passer à l'acte. Il peut avoir des actes médico-légaux, on a dit tout à l'heure des auto-agressivités, surtout quand il y a la prise d'alcool, une instabilité familiale avec cette hyperactivité, son air qui est aut, arrogant, obscène, les troubles de comportement, les dépenses exagérées, ruines sur le plan économique et une biographie qui est orageuse, donc beaucoup de bagarres, beaucoup d'irritabilité et d'agressivité dans ses antécédents.

Il y a un risque élevé de suicide qui peut aller jusqu'à 19%, avec une morbidité psychosociale importante, on note plus de divorces, plus de chômage et le risque d'addiction qui est très élevé. Avec le traitement tumeur régulateur, le traitement préventif, on note une diminution de la fréquence des rechutes, une diminution dans l'intensité des rechutes, dans la durée des accès et bien sûr un espacement entre les accès. Donc les patients sous traitement peuvent faire des accès tous les 4 ans, tous les 5 ans ou bien même tous les 10 ans, ou bien carrément une disparition totale des accès et avoir une vie normale.

Parmi les facteurs de gravité liés aux patients ou à la maladie, on note l'âge précoce du début, le nombre d'épisodes antérieurs et leur gravité, donc plus il y a des épisodes dans les antécédents, plus ces épisodes sont graves, plus le pronostic est mauvais. La présence de symptômes psychotiques en particulier non congruents à l'humeur aussi aggrave le pronostic. L'existence d'une personnalité antérieure pré-morbide aussi, une comorbidité avec des conduites addictives, l'alcool va aggraver l'accès maniaque et l'influence des événements de vie, que ce soit des événements positifs ou des événements négatifs.

Les facteurs de risque liés à la prise en charge, on note la mauvaise observance thérapeutique et les interruptions du traitement. L'utilisation itérative d'antidépresseurs, en particulier tricycliques. Donc si vous ne faites pas bien votre diagnostic devant une dépression et vous donnez un traitement antidépresseur, le patient peut faire un virage maniaque.

L'errance diagnostique devant des tableaux atypiques, ça va entraîner un retard diagnostique et un retard thérapeutique. C'est de mauvais pronostics. Les limites d'efficacité des tumeurs régulateurs ainsi que leurs effets indésirables.

Donc des fois le patient ne va pas répondre à un tumeur régulateur, il va faire beaucoup de rechutes. Ou bien il va l'arrêter à cause des effets indésirables et il va faire beaucoup de rechutes. Parmi les diagnostics différentiels qu'il faut éliminer en premier, il y a le trouble unipolaire.

Le trouble unipolaire, c'est la récurrence que des épisodes dépressifs. Il n'y a pas d'épisodes maniaques ni d'épisodes hypomaniaques durant ce trouble. Et bien sûr, quand vous êtes devant cette dépression, il y a des signes qui peuvent vous orienter vers le risque de virage maniaque si jamais vous mettez votre patient sous antidépresseur.

Notamment si vous avez plus de culpabilité, plus d'idées de suicide, de nombreuses plaintes somatiques, beaucoup d'agitation, d'excitation, d'hostilité, d'irritabilité, d'impulsivité, une hypersomnie, une hyperfagie. Et dans le cas du postpartum aussi, il faut faire attention. Et quand on a une saisonnalité du trouble.

Le patient se sent moins bien en automne et mieux au printemps. On a d'autres signes, notamment quand on a un début précoce du premier épisode dépressif avant 26 ans. Quand on a des traits cyclothymiques, le patient passe rapidement à des hauts et des bas.

Quand on a une biographie orageuse, beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes, beaucoup d'irritabilité, une histoire familiale de troubles de l'humeur, une comorbidité avec les drogues. Et surtout quand on a une rémission trop rapide d'un épisode dépressif majeur sous antidépresseur. Là, il faut faire très attention.

On l'a dit la dernière fois. Tous les antidépresseurs se valent et n'agissent qu'au bout de deux à trois semaines. Donc, si vous avez une rémission spectaculaire au bout d'une semaine, là, il faut faire attention.

Ou bien quelques jours, il faut faire attention. Si vous avez une insomnie aux hypnotiques, ou bien des conduites violentes ou bizarres. Et si vous avez une résistance à plusieurs antidépresseurs.

Devant ces signes, il faut faire attention. Votre patient peut faire un virage maniaque si vous le faites, si vous le mettez sous antidépresseur. Les autres diagnostics, on note l'axé psychotique aigu.

Donc, surtout la première fois, le premier axé psychotique aigu d'allure maniaque. Vous allez voir dans le cours de l'axé psychotique aigu que le premier axé, il peut avoir quatre évolutions. Soit il va avoir un axé sans lendemain, guérison totale et complète, définitive.

Soit il va y avoir la répétition des axés. Soit il va évoluer vers un trouble bipolaire. Soit il va évoluer vers un trouble schizophrénique.

Donc, là, le premier axé peut poser un problème. Diagnostic différentiel avec le trouble bipolaire. La schizophrénie dysthymique, vous avez le diagnostic de schizophrénie.

Qui peut être associé à une dépression ou bien un patient qui peut présenter de l'excitation. Là, on parle de schizophrénie dysthymique. Il faut bien sûr éliminer une pathologie organique.

Lors de certains troubles organiques, on peut trouver, ils peuvent se révéler par un axé maniaque typique. Notamment la neurosyphilis. En post-toxique, des axés psychotiques post-alcooliques ou post-prise toxique du cannabis.

Ils peuvent se manifester par des axés psychotiques aigus d'allure maniaque. Les tumeurs cérébrales frontales peuvent se manifester au début par des axés d'allure maniaque. L'épilepsie temporale aussi peut se manifester par des axés d'allure maniaque.

Il y a aussi certains médicaments qui peuvent entraîner un trouble de l'humeur. Soit dans le sens d'une dépression ou dans le sens de la manie. Notamment les corticoïdes.

Sur le plan étiopathogénique, il y a une origine, un facteur génétique qui est indiscutable. Les études ont montré que l'existence d'un trop bipolaire chez les jumeaux homozygotes donne un risque de 75%. L'existence d'un trop bipolaire chez un parent donne un risque de 15 à 30%.

Au niveau neurobiologique, le trop bipolaire a été expliqué par un déséquilibre adrénaux cholinergique et un dysfonctionnement de l'axe hypophyse sur un alien. A l'IRM, on note des zones d'hyperfixation inexplicables au niveau de la substance blanche et des lésions pseudo-vasculaires des circuits neuronaux entre les régions frontales et temporales. Et au PET-SCAN, on note une diminution du métabolisme du glucose dans le cortex préfrontal avec persistance lors des rémissions et une perte de la balance d'activation entre les différentes régions cérébrales.

La prise en charge est là pour objectif d'abord d'établir et maintenir une alliance thérapeutique, fournir une éducation à propos du trop bipolaire, c'est très important pour que le malade observe son traitement, accroître l'adhérence au traitement, promouvoir un modèle régulier d'activité et de sommeil, et ça c'est très important aussi pour éviter les rechutes. Anticiper les stressors, identifier les nouveaux épisodes préconseillement, et ça c'est grâce aux premiers signes qu'on appelle des signes, des signal d'alarme, parce que des fois les rechutes commencent par les mêmes symptômes, surtout l'insomnie. Dès que l'insomnie apparaît, l'entourage, la famille, ils savent que le patient va rechuter.

Minimiser la détérioration fonctionnelle. L'hospitalisation est indiquée en cas de menace auto ou hétéroagressive, en cas de trouble grave avec manque de soutien social en dehors de l'hôpital, en cas de trouble de jugement significatif, en cas de complication psychiatrique ou médicale générale, et en cas de réponse inadéquate au traitement ambulatoire. Alors en pratique, devant un accès maniaque ou un accès dépressif dans le cadre d'un trouble bipolaire, il faut commencer

à traiter ces accès par les tumeurs régulateurs.

Alors quand on a un accès maniaque ou un état mixte sévère ou résistant qui ne répond pas aux tumeurs régulateurs seul, on ajoute un neuroleptique ou bien on ajoute un autre tumeur régulateur ou bien on fait la sismothérapie. Et quand on est devant une dépression sévère ou résistante au traitement tumeur régulateur, on ajoute un antidépresseur ou un autre tumeur régulateur ou ajouter de la motrigine ou faire la sismothérapie. Mais dans ce cas, on ne donne jamais d'antidépresseur seul.

Toujours l'antidépresseur associé au tumeur régulateur. Et bien sûr, après la stabilisation de ces phases aiguës, on va arrêter progressivement le traitement qu'on a ajouté et laisser le patient sous le traitement qu'on a démarré au début comme traitement tumeur régulateur et comme traitement préventif. Alors la prise en charge des épisodes aiguës maniaques et hypomaniaques commence d'abord par voir ce que reçoit le patient avant.

Pour les patients recevant déjà un traitement psychotrope, vérifier s'il prend bien son traitement, si les doses sont efficaces. Sinon vous augmentez les doses. Si ce n'est pas efficace, changer le tumeur régulateur ou prescrire une association.

Les tumeurs régulateurs disponibles, il y a le lithium, les anticonvulsivants et il y a des antipsychotiques atypiques. Le lithium, il a un rôle préventif des récives maniaques plus que les récives dépressives et il a aussi un rôle préventif du suicide. Bien sûr, l'inconvénient c'est les effets secondaires gênants et il faut obligatoirement faire des dosages sériques régulièrement.

Le valproate, il est moins efficace que le lithium sur la manie aiguë et il est plus efficace chez les cycleurs rapides et les états mixtes et il y a un intérêt du dosage plasmatique. On peut doser si il est efficace ou pas. La carbamazepine, elle est plus efficace chez les cycleurs rapides et les états mixtes et l'inconvénient c'est les associations médicamenteuses qui sont difficiles.

La motrigine, elle est efficace sur les rechutes dépressives plus que maniaques et bien sûr son inconvénient est les problèmes cutanés. Et si vous voyez les différents antipsychotiques atypiques qu'on utilise dans le traitement de l'accès aigu et aussi on peut les utiliser comme traitement préventif. Alors le traitement curatif, l'hospitalisation le plus souvent elle est nécessaire.

En première intention, on a dit on va utiliser un tumeur régulateur en monothérapie. C'est rare que le tumeur régulateur seul suffit. Donc on va utiliser au début soit le lithium soit le valproate.

En deuxième intention, si le patient n'a pas les moyens ou si on ne dispose pas de ces deux médicaments on peut utiliser la carbamazepine. Soit on va utiliser un neuroleptique atypique en monothérapie et vous voyez les différents types de neuroleptiques qu'on peut utiliser le lonzapine, la respiridol, la repiprazole, la quatiapine et la meschilprine. Soit on va utiliser un neuroleptique classique hors AMM parce que les nouveaux guidelines maintenant nous

demandent d'utiliser les neuroleptiques atypiques.

Alors si on utilise les neuroleptiques classiques c'est hors AMM. Ils sont souvent associés à un tumeur régulateur sauf si le patient n'a pas les moyens. Alors on utilise le tumeur régulateur, plus ou moins l'aldol, plus ou moins du largactile, plus ou moins du nozinon.

Donc dans nos ordonnances vous allez trouver des ordonnances variées. Il peut y avoir un tumeur régulateur avec l'aldol seul ou bien le tumeur régulateur avec l'aldol et le largactile, tumeur régulateur avec l'aldol et le nozinon, tumeur régulateur avec le largactile et l'aldol. Des fois quand le patient n'a pas les moyens d'acheter le tumeur régulateur on va utiliser que les neuroleptiques classiques l'aldol, le largactile et le nozinon.

Souvent on utilise des associations. Association de première intention, c'est le lithium ou le valproate, c'est à dire un tumeur régulateur de première intention avec les neuroleptiques atypiques. Donc soit lithium, soit valproate avec la rispéridone ou l'un des deux avec la quétiapine ou avec la lorzapine ou la piperazone ou la miansérine.

En deuxième intention, on peut utiliser l'association de deux tumeurs régulateurs, le lithium et le valproate. Troisième intention, on peut utiliser le lithium ou le valproate avec le neuroleptique classique, la carbamazépine avec le neuroleptique classique, lithium avec la carbamazépine, même si cette association peut donner des effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires neurologiques. La psychothérapie est possible si on a une résistance au traitement et on peut des fois associer des benzodiazépines pour calmer l'agitation et l'anxiété du patient.

Là, un tableau qui vous montre la complexité de la prise en charge, donc pendant la phase aiguë de la manie, les différentes associations qu'on peut utiliser en première et en deuxième intention et pendant aussi la phase préventive, pendant le traitement préventif. En cas de dépression aiguë, quand le patient qui a un trouble bipolaire se présente chez vous, durant la phase dépressive, alors d'abord vous allez faire votre diagnostic, le diagnostic du trouble bipolaire et le patient se présente durant la phase dépressive. S'il est déjà traité, vérifier si la dose est appropriée et l'augmenter si ce n'est pas le cas.

Si nécessaire, vous pouvez prescrire un antidépresseur mais c'est hors AMM et toujours en association avec un tumeur régulateur, jamais d'antidépresseur seul. Il est conseillé de prescrire en première intention un antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, toujours sous couvert d'un tumeur régulateur. D'autres classes d'antidépresseurs peuvent être envisagées mais toujours en association avec un tumeur régulateur, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, la thionexine, la miansérine, la mirtazapine.

Les antidépresseurs tricycliques ne sont pas recommandés en première intention, ils donnent beaucoup de virages maniaques. Débuter l'antidépresseur à la posologie efficace la plus basse possible, donc on ne va pas arriver aux doses efficaces pour une dépression unipolaire. Pour la dépression bipolaire, il faut aller avec la dose la plus basse possible, puis augmenter

progressivement si nécessaire, et arrêter toujours à une dose minimale que la dose qu'on donne pour une dépression unipolaire.

Si besoin, on ajoute les benzodiazépines et les hypnotiques. Aussi, là, les choses deviennent un petit peu complexes. La dépression lors d'un trouble bipolaire type 1 est traitée différemment de la dépression lors d'un trouble bipolaire type 2. Donc le patient qui a un trouble bipolaire peut se présenter vers vous durant sa phase dépressive.

Alors il faut savoir, s'il a fait des antécédents maniaques, vous êtes dans le trouble bipolaire type 1. S'il a fait que des antécédents hypomaniaques et pas d'antécédents maniaques, alors vous êtes dans le trouble bipolaire type 2. Et le traitement, comme vous voyez ici, il est différent. Ici, juste pour vous montrer la complexité de la prise en charge des dépressions bipolaires type 1. Alors, en cas d'amélioration, comment arrêter un antidépresseur chez un patient qui se présente pour une dépression bipolaire? Si on a une rémission ou une baisse notable de sévérité des symptômes depuis au moins 8 semaines, il faut arrêter l'antidépresseur. L'épisode dépressif bipolaire justifie une durée de traitement de consolidation plus courte que la dépression unipolaire.

L'arrêt se fait progressivement sur plusieurs semaines, surtout pour la valaxine, la valafaxine et la paroxétine. Il faut bien sûr informer le patient, c'est très important, de la possibilité de survenue d'une inversion de l'humeur vers un épisode maniaque. La survenue d'un virage maniaque ou hypomaniaque.

Dans ce cas, il doit arrêter le traitement et venir vous voir. La nécessité aussi de respecter la prescription et le risque encouru de sevrage en cas d'arrêt brutal. La nécessité de surveiller l'apparition et de consulter rapidement en cas d'apparition ou d'aggravation des dyssuicidaires, d'anxiété, d'agitation, de signes d'acatisé.

Ils peuvent soit orienter vers des comportements graves qui peuvent engendrer le pronostic vital, soit orienter vers un virage maniaque. Alors ça c'était le traitement curatif de l'accès maniaque ou bien de l'accès dépressif. Après, une fois la phase aiguë et dépassée, il faut bien sûr garder le patient sous un traitement qu'on appelle le traitement d'entretien ou le traitement préventif pour éviter les rechutes.

Alors, de façon résumée, en première intention, vous pouvez garder le lithium seul ou le valproate seul ou le lonzapine ou la quetiapine ou la ripiprazole. En général, vous gardez le traitement, le premier traitement qui a donné efficacité, c'est ce que vous gardez pour traitement préventif. En deuxième intention, vous pouvez donner de la carbamazépine comme traitement préventif ou du lithium ou du valproate ou l'association des deux ou le lonzapine seul ou lithium plus rispéridol, lithium plus la mirtazapine, lithium plus carbamazépine.

L'idéal est de maintenir un seul traitement pour le traitement préventif, mais des fois, on a besoin

d'associer deux médicaments pour éviter les rechutes. Les principes du traitement préventif, respecter l'indication, avoir une coopération du patient, surveillance clinique et paraclinique, la durée du traitement et les avis ou au minimum 5 ans. Plusieurs produits sont utilisés qu'on appelle les tumeurs régulateurs.

Ces tumeurs régulateurs, bien sûr, il faut une surveillance clinique par des examens réguliers et des examens et des bilans régulièrement. Vous allez les voir en détail dans le cours des tumeurs régulateurs. Là aussi, pour voir la complexité de la prise en charge des rechutes, les différents traitements qu'on utilise en première intention et en deuxième intention.

Le trouble bipolaire, c'est un trouble qui est chronique et on est obligé de traiter les différentes phases. Donc, on traite la manie aiguë, la dépression aiguë, les manifestations persistantes ou résiduelles entre les différentes phases, la prévention des rechutes maniaques, la prévention des rechutes dépressives. Et aussi, chose qui est importante, il faut agir sur les facteurs précipitants ou déstabilisants pour éviter les rechutes.

Et bien sûr, pour arriver à ça, on passe par la psychoéducation dont les objectifs sont comprendre la nature du trouble bipolaire et de stigmatiser la maladie pour le patient et pour la famille. Prévenir les rechutes par identification des facteurs déclenchants, par repérage précoce des signes cliniques. On a dit que certains patients font les rechutes chaque fois avec les mêmes symptômes.

Apprendre à réagir face à ces symptômes, renforcer la compléance au traitement et améliorer la qualité de vie. Alors, l'entourage joue un rôle capital de première intention. C'est la famille qui va détecter les premiers signes des rechutes.

Ils ont besoin d'un soutien actif au quotidien. Ils sont aux premières lignes en cas d'alerte. Ils sont aussi exposés au stress de la vie avec un malade et au risque de déstabilisation.

Donc, ils ont besoin de soutien et ils ont besoin aussi d'avoir une psychoéducation pour savoir comment se comporter avec le patient. Parmi les recommandations qu'on donne à l'entourage, ayez des activités avec votre proche, ne l'isolez pas. Sachez réagir devant les prodromes d'un axé maniaque.

Les soins, vérifiez que le patient prend son traitement. Protection financière, quand vous constatez qu'il y a des symptômes, des signes d'alarme que le patient va rechuter, il faut bien sûr faire attention. Prendre le chéquier par exemple, la carte bleue, surveiller le patient pour qu'il ne dépose pas beaucoup d'argent.

Prendre les clés de la voiture aussi parce qu'il peut avoir des conduites à risque. Ne vous isolez pas, ça c'est un conseil pour l'entourage. Ils doivent garder du temps pour eux et soyez en contact avec le système de soins en cas de besoin.

Et devant les prodromes d'un axé maniaque, le conseil qu'on donne à la famille, c'est limiter les simulations et les bruits. Avoir des conversations brèves avec le patient. Ne pas tenter de le raisonner, surtout quand il est délirant et ne pas avoir de chantage affectif.

Essayez juste de rester ferme et pour gagner du temps, donc refusez de répondre à toutes les demandes. Restez critique devant certains projets qui sont irréalisables et gagnez du temps pour l'amener en consultation et pour assurer la sécurité du patient. La période intercritique, c'est une période qui ne veut pas dire qu'elle est asymptomatique.

On a des épisodes et symptômes dépressifs subsyndromiques qui dominent la vie des patients bipolaires et sont plus handicapants et sources de souffrance que les symptômes hypomaniaques. Cette souffrance subsyndromique fait le lit de la sensibilité exacerbée aux événements de vie et bien sûr de là aux rechutes. Ceci a comme conséquence de garder le traitement tumorélateur de façon permanente, le traitement préventif de façon permanente.

Donc pour traiter les phases critiques, les phases aiguës et pour aussi les syndromes subsyndromiques au cours des phases intercritiques. Et bien sûr, il faut une indication importante de la psychoéducation du patient et de la famille. Les troubles bipolaires, c'est un diagnostic qui est difficile et il faut insister pour chercher les phases hypomaniaques et les phases maniaques.

5 à 10 ans pour faire le diagnostic, c'est un retard diagnostique et thérapeutique qui peut aggraver le pronostic. Quatre médecins consultés avant de confirmer le diagnostic, le traitement est souvent difficile, il y a des patients qui ne se stabilisent pas, même avec le changement, même avec l'association de plusieurs médicaments, il y a des patients aussi qui font beaucoup de rechutes. Le pronostic est réservé, on a beaucoup de tentatives de suicide et de suicides réussis.

Mais comme vous le savez, il y a des célébrités qui ont vécu avec ce trouble et qui ont même été hyper créatifs avec ce trouble. Et je vous remercie.